Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 15ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº **0103258-57.2021.8.17.2001**

AUTOR: ANNA CAROLINA DE SOUSA SILVA FERREIRA

RÉU: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

SENTENÇA

Vistos, etc…

ANNA CAROLINA DE SOUSA SILVA FERREIRA, já qualificado, por meio de seu advogado legalmente constituído, propôs, quando viva, a presente **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO)**, em face da **GEAP SAÚDE– AUTOGESTÃO EM SAÚDE**, alegando resumidamente que (id. 91436528) que:

1- Está grávida e é beneficiária no plano de assistência à saúde da GEAP (CIB: 1101 0110 5514 0154), tendo como titular o seu esposo, estando em dia com os pagamentos.
2- De acordo com laudo emitido pela médica hematologista, Dra. Carolina Luisa Cardoso Militão, CRM 7871/PE, a Autora está na 35ª (trigésima quinta) semana de gestação e foi diagnosticada com trombofilia polimorfismo PAI-1 4G/5G e heterozigoto para o C677T do MTHFR.
3- O tratamento da doença deve ser iniciado imediatamente por meio do medicamento Enoxaparina Sódica (CLEXANE) 40mg ao dia como profilaxia de TVP (trombose venosa profunda). Segundo a receita médica, a utilização do medicamento deverá ser suspensa 24 (vinte quatro) horas antes do parto e reestabelecida 12 (dose) horas após o parto com utilização contínua até o 40º (quadragésimo) dia após o parto.
4. O medicamento deve ser administrado por profissional de saúde, conforme dispõe na bula do próprio laboratório fabricante, por se tratar de injeções subcutâneas e bolus intravenoso.
5- A Autora solicitou o medicamento à GEAP, no dia 07 de outubro de 2021, no entanto, foi negado em 14 de outubro de 2021, conforme resposta a seguir:

> Prezada Sra. Anna Carolina, bom dia! Por deliberação da Gerência Regional de Pernambuco e em atendimento NIP- demanda 5372712. Após contato através do número (81) (81)992408596 no dia 14.10.2021 as 11:22 falamos com a Sra. Anna Carolina. Esclarecemos que o medicamento Versa® (enoxaparina sódica) é de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde apenas nos casos de pacientes internados ou que estão em tratamento oncológico. Conforme PARECER TÉCNICO Nº 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS(em anexo), é de obrigatoriedade da operadora a cobertura de medicamentos, em âmbito ambulatorial, conforme abaixo: Medicamentos antineoplásicos empregados na quimioterapia oncológica ambulatorial; Medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento do câncer; Medicamentos adjuvantes, ou seja, os medicamentos empregados de forma associada aos quimioterápicos; Medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e medicamentos adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. Considerando que não é o caso da paciente, a cobertura não se faz obrigatória.

6. Inconformada com a situação, apresentou reclamação na ANS – Agência Nacional de Saúde, no mesmo dia.
7. Conforme destaca o laudo médico, (Anexo 05, pág. 02), a falta do uso desse medicamento poderá causar a morte da Autora e/ou do feto, já que a trombofilia é a condição em que a pessoa tem maior facilidade de formar coágulos de sangue, aumentando o risco de problemas graves como trombose venosa profunda, ataque vascular cerebral, embolia pulmonar, aborto, descolamento prematuro de placenta, entre outras complicações:

> "Paciente Anna Carolina de Sousa Silva Ferreira está gestante, tem trombofilia necessitando de uso de HBPM – Clexane 40mg como profilaxia de TVP que caso ocorra pode levar a grave morbimortalidade materna e ou fetal. Esta medicação deverá ser usada durante a gestação e até 40 dias após parto. D68.3 / 002.3"

8. O parto está previsto para o dia 04 de novembro de 2021, conforme autorização de internação para cesariana, emitida pela própria Requerida,(Anexo 16). O que também se comprova através do atestado para afastamento laboral emitido pela médica obstetra Dra. Eva Mércia P. Paiva CRM 6168/PE, em 22/10/2021.

Pelo exposto, requereu: (a) a concessão de tutela provisória de urgência antecipada para que a ré FORNEÇA O MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE®) 40mg EM QUANTIDADE SUFICIENTE A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO ATÉ O 40° DIA APÓS O PARTO, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO, RESTRIÇÃO OU EXCLUSÃO; (b) a confirmação da tutela em sentença.

Na decisão de id. nº 91501455, este Juízo concedeu a liminar, vejamos o dispositivo da decisão:

> EM FACE DO EXPOSTO E FUNDAMENTADO DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, NOS MOLDES DO ART. 300 DO CPC, PELO QUE DETERMINO QUE SEJA INTIMADA A DEMANDADA GEAP SAÚDE– AUTOGESTÃO EM SAÚDE, A FIM DE QUE, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS, A PARTIR DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO, FORNEÇA O MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE®) 40MG EM QUANTIDADE SUFICIENTE ATÉ O 40° DIA APÓS O PARTO, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO, RESTRIÇÃO OU EXCLUSÃO, NA FORMA PRESCRITA NO LAUDO MÉDICO E NA SOLICITAÇÃO DE MEDICAÇÃO ACOSTADOS SOB IDs. 91437446 e 91437451, A FIM DE QUE SEJA POSSÍVEL REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO À AUTORA ANNA CAROLINA DE SOUSA SILVA FERREIRA, CPF Nº 028.262.274-83, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, A CONTAR DA INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO, CONFORME ARTIGO 497 DO CPC.
>
> No mais:
> 1.DETERMINO que a secretaria proceda com a citação da parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, com a advertência do artigo 344 do CPC.
> 2. Diante do fato notório da pandemia do COVID-19, bem como das determinações exaradas por este Tribunal, através da Portaria Conjunta nº 05, de 17 de março de 2020, e do art. 14 do Ato nº 1027/2020, deixo de designar a audiência conciliatória do art. 334 do CPC, podendo as partes, a qualquer tempo, conciliarem e requerem a homologação judicial.
> 3. O prazo para apresentação de contestação se iniciará no dia seguinte à data da juntada aos autos do último expediente cumprido, nos termos do art. 231, inciso I, do CPC.
> 4. Cumpra-se.

Devidamente citada, a demandada apresentou sua contestação, onde alega resumidamente que (petição de id. 92039593):

1. A GEAP Autogestão em Saúde é fundação de direito privado, classificada perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS como Operadora de Saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, motivo pelo qual o CDC não se aplica ao caso concreto.

2. A GEAP possui uma das melhores carteiras do mercado no que diz respeito à mensalidade. O quantitativo do valor mensal de cada plano é definido após o devido estudo atuarial desta operadora (válido por 12 meses), o qual não inclui procedimentos Extra Rol.
3. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, definida como Agência Reguladora vinculada ao Ministério da Saúde, responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil, "estabelece a COBERTURA ASSISTENCIAL OBRIGATÓRIA a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados" Art. 1º RN Nº 470.
4. Quando a Agência em sua RN nº 470, Art. 1º declara que estabelece COBERTURA ASSISTENCIAL OBRIGATÓRIA, todo o resto dos procedimentos e medicamentos que não estão no Rol ou não preenchem as Diretrizes de Utilização NÃO SÃO OBRIGATÓRIOS pela saúde suplementar.
5. Os planos de saúde administrados pela GEAP possuem cobertura contratual mínima obrigatória em conformidade com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, excetuando aqueles anteriores à Lei 9656/98 (GEAP Saúde). O Rol de procedimentos é atualizado periodicamente (mais ou menos a cada dois anos) pela ANS.
6. Neste sentido, resta imperioso destacar que o medicamento Versa® (enoxaparina sódica) é de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde apenas nos casos de pacientes internados ou que estão em tratamento oncológico.
7. De acordo com a CI/GEAP/GEMED/ Nº 012/2016 que informa a respeito do mecanismo de regulação da enoxaparina sódica, ressaltando que o medicamento CLEXANE® é de cobertura obrigatória de acordo com o Rol 387 da ANS, NÃO SENDO DE COBERTURA QUANDO SE TRATA DE REGIME AMBULATÓRIAL.
8. Os procedimentos e tratamentos que a GEAP oferece é proporcional ao que seus beneficiários pagam e NÃO HÁ PREVISÃO CONTRATUAL para cobertura de procedimentos EXTRA ROL.
9. Logo, o custeio desse medicamento pela promovida não foi autorizado por não estar em conformidade com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e as Diretrizes de Utilização da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, razão pela qual houve a aludida recusa.
10. Vale frisar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, as Diretrizes de Utilização (DUT) e as Diretrizes Clínicas (DC), pela Agência Nacional de Saúde, estão pautados nas evidências científicas atuais sobre eficácia e efetividade, tendo como referência estudos reunidos pelo Ministério da Saúde. Portanto, tais estudos são necessários para determinar a pertinência dos procedimentos e indicações clínicas, para que só então possam ser objeto de incorporação nas futuras atualizações do Rol, conforme previsão legal e regimental da ANS.
11. A ANS restringe a obrigatoriedade de cobertura de determinados procedimentos apenas em determinados casos, pois para esses casos o tratamento estudado se mostrou eficaz.
12. Assim, frisa-se que a Requerida não negou cobertura à realização de tratamento da paciente indiscriminadamente, mas tão somente se valeu dos normativos e imposições da própria agência reguladora.
13. Dessa forma, considerado que a beneficiária não se enquadra nas diretrizes de utilização – DUT da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS supracitadas, o fornecimento deste medicamento não é obrigatório. A única alternativa seria a previsão contratual do medicamento no negócio jurídico firmado com o beneficiário.
14. Entretanto, não consta de tal instrumento qualquer cláusula que obrigue a demandada a cobrir o medicamento requerido pelo autor.

Pelo exposto, requereu a improcedência da ação, diante da inexistência de obrigação legal ou contratual da ré em garantir o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica (CLEXANE)40mg.

Réplica de id. 99130350.
Despacho de provas (id. 99713209).
A parte ré pediu o envio de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para que a agência reguladora informe se a requerida agiu de maneira equivocada e ofício à GGREP Gerência-Geral Regulatória da Estrutura dos Produtos, órgão que, segundo a estrutura

organizacional prevista na Resolução Regimental Nº 01, da ANS2 , é responsável por elaborar e propor normas visando à garantia e à manutenção de todos os benefícios de acesso à cobertura previstos na Lei nº 9.656, de 1998 (petição de id. 100489389).
A autora promoveu a juntado de cópia do Agravo de Instrumento interposto pela demandada em face da decisão proferida neste processo e se contrapôs as provas requeridas pela ré (id. 101950908).
Julgamento do Agravo de Instrumento (id. 104804013).

Despacho indeferindo a prova requerida pela ré (id. 105117270).
Despacho encerrando a fase de instrução e intimando as partes para Razões Finais (id. 120326667).
Razões Finais demandante (id. 125641904).
Razões Finais demandada (id. 125708498).

ISSO POSTO, PASSO A DECIDIR:

1. DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE:

De logo, faço constar que a Constituição Federal prescreve em seu artigo 1º, inciso III que:

> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
> (...)
> III - a dignidade da pessoa humana.
> (...)

Especificamente em seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais, A CF/88 prescreve a inviolabilidade do direito à vida.
Ora, o direito à vida é sem dúvida alguma o mais importante de todos os valores, pois dele emana a eficácia de todos os demais, *v.g.*, saúde, moradia.
Desta feita, é de absoluta prioridade para o Estado preservar a vida dos indivíduos, prestando todo o auxílio necessário para que, com esse direito assegurado, o cidadão possa exercer todo o feixe de direitos fundamentais que dele emanam.
Por sua vez, o artigo 196 da Carta Política traz expressamente que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, ao prescrever que:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Todavia, embora seja dever do Estado a assistência à saúde, esse serviço é de livre iniciativa privada, consoante artigo 199 da CRFB/88:

> Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Verifica-se, pela leitura dos artigos supracitados, que a iniciativa privada pode promover à assistência à saúde, entretanto,tem que ter em mente que "cuida" do mais importantes de todos os valores garantidos ao cidadão, qual seja: a vida, pois é da vida que emanam todos os direitos fundamentais.
Por isso, o plano de saúde privado deve respeitar todas as normas constitucionais que versem sobre a garantia da saúde dos pacientes, evidentemente, daquele grupo fechado beneficiário do serviço, como no caso dos clientes da demandada deste processo.

Dessa forma, deve às normas contratuais estipuladas entre o particular, prestador do serviço de saúde e os contratantes serem regidas pelas normas supra.

2. DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES:

Em relação ao tema trazido neste item, destaco que há nos Tribunais Pátrios um verdadeiro inconformismo quanto à inaplicabilidade do CDC nas relações entre segurados e planos de saúde de autogestão.
Sobre o tema em questão, posiciono-me favorável a aplicabilidade do CDC e lamento, data a máxima vênia, a tese que saiu vencedora junto a Corte Superior.
Todavia, mesmo lamentando, sou obrigada a me curvar ao dito entendimento, uma vez que a Segunda Seção (Direito Privado - que está vinculado a 3ª a 4ª Turma) pacificou a divergência entre as turmas com a definição da inaplicabilidade do CDC, senão vejamos:

> RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FORMA PECULIAR DE CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia, sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido.
> (REsp 1.285.483/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 16/8/2016).

Pelo que, em que pese discorde frontalmente dessa inaplicabilidade do CDC, sou obrigado a adotá-la, motivo pelo qual no julgamento da demanda não será aplicada a legislação consumerista.

c) DOS FATOS INCONTROVERSOS:

Faz-se necessário elucidar que o Digesto Processual Civil prescreve em seu artigo 36, que cabe (...) *ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir*.
Ademais, prescreve ainda o artigo 341 que *Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas* (...).
Ora, analisando a tese de defesa, verifico que o demandado não se contrapõe aos seguintes fatos narrados na inicial, sendo desnecessária, por conseguinte, a produção de provas, pela presunção de veracidade dos fatos: (a) a qualidade de segurado da autora e a ausência de mensalidades em aberto; (b) que a autora estava, quando do ajuizamento do processo, na 35ª (trigésima quinta) semana de gestação e foi diagnosticada com trombofilia polimorfismo PAI-1 4G/5G e heterozigoto para o C677T do MTHFR; e que (c) que o médico que acompanha a paciente prescreveu medicamento Enoxaparina Sódica (CLEXANE) 40mg ao dia como profilaxia de TVP (trombose venosa profunda) e que tal medicamento era para ser suspenso 24 (vinte quatro) horas antes do parto e reestabelecido 12 (dose) horas após o parto com utilização contínua até o 40º (quadragésimo) dia após o parto; (d) que o medicamento não foi autorizado pelo plano; e (e) que a falta do uso desse medicamento poderá causar a morte da Autora e/ou do feto, já que a trombofilia é a condição em que a pessoa tem maior facilidade de formar coágulos de sangue, aumentando o risco de problemas graves como trombose venosa profunda, ataque vascular cerebral, embolia pulmonar, aborto, descolamento prematuro de placenta, entre outras complicações.
Desta feita, verifica-se que os fatos supracitados são tidos por incontroverso, sendo desnecessária a prova de sua veracidade.

Cumpre esclarecer que a tese da defesa, quanto ao mérito da demanda, é formulada na tentativa - em resumo - de justificar a legitimidade do plano de saúde em negar o custeio do medicamento, sob as seguintes alegações: (a) falta de previsão do Rol da ANS e falta de previsão contratual; e que (b) o medicamento enoxaparina sódica é de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde apenas nos casos de pacientes internados ou que estão em tratamento oncológico.
Conclui-se, portanto, que a demandada não nega a utilidade e necessidade do tratamento, pois sustenta sua negativa com base na falta de previsão de cobertura no Rol da ANS e no contrato celebrado entre as partes, de forma que é inconteste que o medicamento era útil e imprescindível para salvaguardar a vida da demandante e do feto que ela carregara quando do ajuizamento da ação.

Ex positis, é unicamente sobre os pontos da defesa (controversos nos autos) que este Juízo passa a enfrentar, uma vez que os pontos incontroversos supramencionados são presumidamente verdadeiros, dentre eles a doença que acometia a gestante e a necessidade e utilidade do medicamento para salvar a sua vida e a vida da criança.

4. DA (I)LEGALIDADE DE NEGATIVA DO MEDICAMENTO:

Quanto à necessidade do tratamento, por amor ao debate, faço destacar que consta no processo laudo médico que demonstra cabalmente que o médico assistente o requereu expressamente e ainda alertou a necessidade de início imediato do tratamento, pois a sua falta poderia levar à morte da gestante ou do feto.
Ou seja, o tratamento em questão de fato foi prescrito pelo médico que acompanha o paciente.
Desta feita, resta suficientemente comprovado a necessidade urgente - **no caso concreto** - da realização do tratamento autorizado pela Decisão Provisória de Urgência, pois o médico responsável, além de ter requerido o procedimento justifica a sua perene necessidade para salvaguardar a vida do requerente, pois informa que o atraso no uso da droga poderia causar a morte dela ou do bebê que ela carregava.
Feitas essas ponderações, passo a enfrentar a tese trazida pela defesa que sustenta que a negativa de custeio do tratamento se deu de forma devida.
Dentro deste cenário, faço destacar que a Jurisprudência pátria é uníssona ao se posicionar pela abusividade da negativa do plano de saúde em não autorizar a realização de tratamentos prescritos pelos médicos responsáveis, uma vez que, sendo a especialidade coberta pelo plano em questão, cabe ao profissional habilitado promover o cuidado do paciente, requerendo os procedimentos necessários.
Desta feita, não cabe ao plano de saúde avaliar as prescrições médicas, fazendo juízo de valor do que deve ou não ser autorizado, ou seja: o contrato de seguro saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas.
No caso em comento, deve ser observado os princípios da boa-fé e da confiança, sendo vedado à seguradora perceber por anos a contribuição da segurada para se esquivar da cobertura do tratamento indispensável ao tratamento do segurado, justamente quando do surgimento da doença.
O Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco se filia ao posicionamento aqui esposado reiteradamente quanto à abusividade da negativa de autorização de procedimentos, vejamos julgados recente a respeito do tema:

> PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO E MEDICAMENTOS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1- Procedimento solicitado por profissional médico como medida imprescindível ao tratamento da saúde do segurado. 2- Não pode ser negada cobertura a tratamento e medicamentos pelo simples fato de não constarem no guia da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, uma vez tenham sido prescritos pelo médico assistente e a enfermidade a ser tratada esteja prevista no contrato firmado entre as partes. 3- Cabível a indenização por danos morais em decorrência do

agravamento do abalo psicológico em que se encontra o paciente, estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4- Montante fixado a título de danos extrapatrimoniais em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-PE - AGV: 3127691 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/09/2013, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2013)

TJ-PE - Apelação APL 3701862 PE (TJ-PE) (http://tj-pe.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18393 apl-3701862-pe) Data de publicação: 27/04/2015 Ementa: Apelação Cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura de exame de Tomografia de Coerência Ótica - OCT. Danos morais configurados. Manutenção do valor indenizatório. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime. I - Pode o contrato de seguro saúde limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas. II - A medicina em constante evolução, razão pela qual novas tecnologias relacionadas a exames e procedimentos médicos surgem a todo momento. Deste modo, não se pode falar em ausência de cobertura contratual de determinados exames que provavelmente nem existiam à época da contratação do plano de saúde em questão. IV - Nos contratos de plano de saúde devem incidir os princípios da boa-fé, da confiança, da hipossuficiência e da vulnerabilidade não sendo legítimo à seguradora perceber por anos a contribuição do segurado para se esquivar da cobertura do tratamento indispensável à permanência da vida dele justamente quando do surgimento da doença. V - A conduta da operadora em negar custeio ao medicamento necessitado pela paciente frustrou a legítima expectativa de ser protegida no momento de infortúnio. Nessa ocasião, o dano é claro e presumido, considerando-se o abalo à moral da vítima, pois teve o estado de tensão psicológica e de angústia intensificados pelo tratamento recusado.VI - Valor indenizatório mantido em R$8.000,00, pois chega a ser inferior aos parâmetros adotados pelo STJ e por esta Corte em casos análogos.VII - Recurso não provido por unanimidade

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HEMODIÁLISE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE NÃO PODE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO. DEVER DA OPERADORA DE SAÚDE EM CUSTEAR O TRATAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO APELO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A REVISÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂMIME.
(TJ-PE - AGV: 4156727 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 22/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2016)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA E MATERIAL INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. IMPLANTE DO SISTEMA ANGEL/MED GUARDIAN. APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS ENVOLVENDO OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE QUE ATUAM NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO É POSSÍVEL À OPERADORA LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS. CABE AO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE A ESCOLHA. DECISÃO TÉCNICA. PRECEDENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. MANTIDA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO.
(TJ-PE - AGV: 3991422 PE, Relator: Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, Data de Julgamento: 15/12/2015, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CDC. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO. NA ORIGEM: AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLOCAÇÃO "UTEROSCÓPICA DE DUPLO J". EXCLUSÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. CIRURGIA REQUERIDA SEGUNDO DIAGNÓSTICO DO PROFISSIONAL COMPETENTE. DEVER DA

OPERADORA DE SAÚDE EM CUSTEAR O TRATAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO APELO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A REVISÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂMIME.
(TJ-PE - AGV: 4034788 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 20/10/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2015)

De mais a mais, o fato do tratamento não está previsto no Rol de procedimentos obrigatórios da ANS não justifica a sua negativa quando o médico assistente atesta a sua necessidade, pois há muito tempo a jurisprudência já definiu que o rol supracitado nada mais é que um rol de coberturas mínimas, senão vejamos julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

Apelação Cível. Plano de saúde. Tratamento de radioterapia com técnica de modulação de intensidade no feixe. Negativa de cobertura. Abusividade. Incidência da legislação consumerista. Rol de procedimentos elencados pela ANS que serve apenas como referência para cobertura assistencial mínima. Dever de cobertura. Recurso não provido por unanimidade.
I **- Pode o contrato de seguro saúde limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas.**
II - **Se o plano possui cobertura para a especialidade de oncologia e o tratamento mais eficiente a ser ministrado ao paciente nesse caso, segundo entendimento médico consiste radioterapia com técnica de modulação de intensidade no feixe não há razão para excluir o referido procedimento da cobertura securitária, sob pena de se negar ao beneficiário o tratamento adequado à sua enfermidade e, por consequência, ferir a própria finalidade do contrato firmado entre as partes.**
III - No caso, o médico assistente do segurado justificou a necessidade do tratamento em questão por ser a única opção terapêutica com finalidade curativa e ainda destacou a necessidade de urgência da autorização de cobertura devido à velocidade de aumento do tumor.
IV - O Rol da ANS não é taxativo, contendo apenas a referência para a cobertura assistencial mínima obrigatória dos planos de saúde.
V - A previsão dos riscos segurados e as limitações de cobertura no contrato de seguro não consistem, por si só, em ilegalidade. No entanto, a possibilidade de predeterminar os riscos cobertos não justifica a estipulação de cláusulas abusivas e contrárias às disposições do CDC.VII - Recurso apelatório não provido por unanimidade.
(Processo APL 3850531 PE Orgão Julgador 3ª Câmara Cível Publicação 14/01/2016 Julgamento 17 de Dezembro de 2015 Relator Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto)

Quanto a este tema (taxatividade ou não do rol), destaco que tempos atrás existiu uma séria insegurança jurídica, pois a divergência entre a 3ª e 4ª Turmas do STJ afetou tal tema para análise.
Antes de a Corte definir sobre a taxatividade ou não do rol foi publicada nova Lei reforçando a taxatividade do rol, situação que levou o STJ (2ª Seção) a definir pela taxatividade rol, entretanto com algumas exceções, chegando-se a conclusão que a tese adotada foi a da taxatividade mitigada.
Entretanto, em 21/09/2022, foi sancionada nova Lei de nº 14.454/2022, que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e trata dos planos privados de assistência à saúde.
Nesta nova Lei as operadoras de planos de saúde estão obrigadas a financiar tratamentos que não estiverem na lista mantida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Desta feita, a discussão sobre a natureza exemplificativa ou taxativa do rol fora sepultada com a nova Lei 14.454/2022 que previu expressamente que tal rol é um rol de cobertura mínima.
Por conseguinte prevendo a Lei a exemplificatividade do rol, não cabe a este Juízo acolher a defesa, de forma que se mostra ilegal a negativa de cobertura da técnica com base na ausência de sua previsão no rol, pois a Lei que trata dos planos de saúde, como já esclarecido nesta sentença, prevê claramente que o rol é exemplificativo.

Vê-se portanto, à luz da jurisprudência supracitada, que o contrato do plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas, pois a indicação do tratamento devido cabe ao médico do paciente.
Pela jurisprudência supra se infere também que o rol de coberturas obrigatórias da ANS é um rol mínimo, prevalecendo a indicação do médico assistente.
De forma que eventual alegação de que o contrato não cobre aquele procedimento ou que ele não consta no rol de coberturas obrigatórias da ANS não pode prosperar.

Esclareço ainda que mesmo que o medicamento fosse experimental para o caso da autora, o que não é o caso, não afastaria a obrigação do plano em autorizar a cobertura quando requerido pelo médico assistente, vejamos o que o STJ diz a respeito do tema no mesmo precedente já citado nesta sentença:

> RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. **NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL**. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. **USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO**. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
> (...)
> 3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS.
> (...)
> 5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I).
> 6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label).
> 7. **Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo**.
> 8. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica.
> (...)
> 12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.
> (REsp. 1.769.557 - CE (2018/0255560-0). Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julg. 13/11/2018).

Desta feita, à luz desta fundamentação, outra solução não há que não seja julgar procedente o pedido autoral com a condenação da ré para que ela autorize e custeie o medicamento, conforme prescrição médica, tornando definitiva a tutela provisória de urgência concedida na decisão de id. 91501455.

DECISÃO:

Pelo exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado na inicial, e, por conseguinte:

a) Torno definitiva a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência de id. 91501455, e, por conseguinte, condeno a demandada a custear integralmente O MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA (CLEXANE®) 40MG EM QUANTIDADE SUFICIENTE ATÉ O 40º DIA APÓS O PARTO, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO, RESTRIÇÃO OU EXCLUSÃO, NA FORMA PRESCRITA NO LAUDO MÉDICO E NA SOLICITAÇÃO DE MEDICAÇÃO ACOSTADOS SOB IDs. 91437446 e 91437451, A FIM DE QUE SEJA POSSÍVEL REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO À AUTORA ANNA CAROLINA DE SOUSA SILVA FERREIRA, CPF Nº 028.262.274-83, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
b) Condeno, por fim, a demandada a restituir a demandante no valor das custas e taxas judiciais recolhidas para o ingresso da demanda, corrigido (encoge) e com juros legais (1% a.m.) contados desde do recolhimento das custas pela autora até a data da restituição.

Pelo que **EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, com base no artigo 487, inciso I, do CPC.

Arbitro os honorários a serem pagos pela demandada em favor dos advogados da demandante no importe de 10% sobre o valor da causa.
Condeno a demandada em custas processuais finais, caso existam valores pendentes de recolhimento em favor do TJPE.
Intimem-se as partes desta sentença.

Após o trânsito em julgado, determino que sejam tomadas todas as medidas legais para salvaguardar o interesse público no recolhimento das custas processuais finais, caso existentes, pela demandada em favor do TJPE.

Cumpridas todas as determinações supra, arquive-se o processo.

P.R.I.

Recife, 1º de agosto de 2023.

LUZICLEIDE MARIA MUNIZ VASCONCELOS
Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUZICLEIDE MARIA MUNIZ VASCONCELOS
03/08/2023 11:48:39
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 139835127

23080311483974300000136579913

IMPRIMIR GERAR PDF